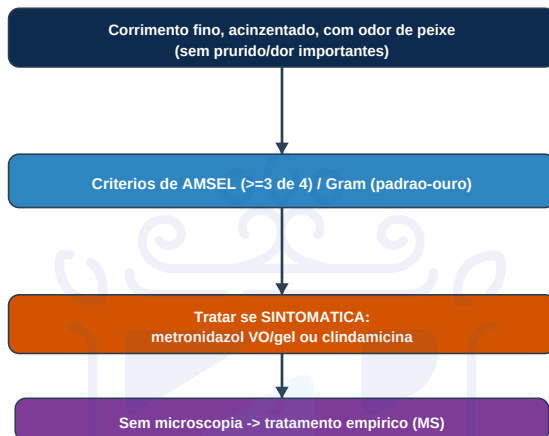


VAGINOSE BACTERIANA — CRITÉRIOS DE AMSEL

FLUXOGRAMA — CORRIMENTO COM ODOR

VAGINOSE — DISBIOSE, NÃO IST CLÁSSICA



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Disbiose vaginal: substituição dos *Lactobacillus* pela flora anaeróbia (*Gardnerella vaginalis* e outras)
- Causa MAIS COMUM de corrimento vaginal (prevalência ~23-29%)
- Associada a práticas sexuais (novo/múltiplos parceiros); preservativo é fator PROTETOR
- Aumenta o risco de adquirir ISTs (HIV, gonorreia, clamídia, tricomoníase, HPV)

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

SINTOMA CARDINAL

- Corrimento FLUIDO, em maior quantidade, acinzentado/leitoso, que reveste as paredes vaginais
- ODOR de peixe (que piora após relação/menstruação)
- SEM prurido, ardência ou inflamação importantes (diferente de candidíase/tricomoníase)
- A ausência de mau odor torna a vaginose pouco provável (RV negativa 0,07)
- Quantidades normais de lactobacilos tornam o diagnóstico improvável

DIAGNÓSTICO — CRITÉRIOS DE AMSEL (>= 3 de 4)

Critério	Achado
Corrimento característico	Homogêneo, fino, leitoso, revestindo as paredes vaginais
Clue cells	Células-guia à microscopia (epitélio com bactérias aderidas)
pH vaginal	> 4,5
Whiff test (teste das aminas)	Odor de peixe ao adicionar KOH 10%

PADRÃO-OURO E ABORDAGEM SINDRÔMICA

DIAGNÓSTICO

- Padrão-ouro: coloração de GRAM da secreção vaginal (proporção lactobacilos x patógenos)
- Sem microscopia/pH/KOH disponíveis: o MS recomenda tratamento EMPÍRICO para as 3 causas comuns (vaginose, candidíase, tricomoníase)
- NÃO há indicação de rastrear vaginose em assintomáticas
- Oferecer testagem para HIV e outras ISTs a toda mulher com diagnóstico de vaginose

TRATAMENTO (apenas SINTOMÁTICAS)

Rx ESQUEMAS

Metronidazol 500 mg VO 12/12h por 7 dias (1a linha)
OU Metronidazol gel vaginal 0,75% 1x/dia por 5 dias
OU Clindamicina creme vaginal 2% 1x/dia por 7 dias (alternativa)
NÃO é necessário abster-se de álcool com metronidazol (sem reação dissulfiram-símile real - CDC)
Gestante sintomática: tratar (metronidazol VO é seguro). Assintomática: tratar só se histórico de parto pré-termo/complicações (PCDT-MS)
Usar preservativo durante o tratamento; NÃO fazer ducha vaginal (risco de recorrência)

ORIENTAÇÕES E PARCEIRO

PONTOS-CHAVE

- Tratamento indicado SOMENTE para sintomáticas (e gestantes de risco conforme MS)
- NÃO se trata o parceiro de rotina (vaginose não é IST clássica), embora práticas sexuais influenciem a recorrência
- Evitar duchas intravaginais; preservativo protege
- Testar para HIV/ISTs
- Recorrência é comum — reavaliar adesão e fatores de risco

MODELO DE ORIENTAÇÃO / SEGUIMENTO

RESUMO

- Mulher com corrimento fino acinzentado e odor de peixe; Amsel ___/4 (pH > 4,5, clue cells, whiff +).
- Diferenciais excluídos: candidíase (prurido, grumoso), tricomoníase (amarelo-esverdeado, colo em framboesa).
- Conduta: metronidazol VO 7 dias (ou gel); testagem para ISTs/HIV oferecida.
- Orientar preservativo e evitar duchas; tratar apenas se sintomática.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Mulher com corrimento fino acinzentado, odor de peixe, pH 5,0, clue cells e whiff test positivo. Diagnóstico e tratamento?

- A) Candidíase — fluconazol
- B) Vaginose bacteriana — metronidazol VO 500 mg 12/12h por 7 dias
- C) Tricomoníase — apenas creme vaginal
- D) Gonorreia — ceftriaxona
- E) Vaginose — não tratar mesmo sintomática

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Quantos critérios de Amsel são necessários para o diagnóstico clínico de vaginose bacteriana?

- A) 1 de 4
- B) Pelo menos 3 de 4
- C) Todos os 4 obrigatoriamente
- D) 2 de 5
- E) Nenhum; o diagnóstico é apenas laboratorial

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é o exame padrão-ouro para o diagnóstico de vaginose bacteriana?

- A) Cultura de secreção
- B) Coloração de Gram da secreção vaginal
- C) PCR para Gardnerella
- D) Citologia oncótica
- E) USG transvaginal

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre o rastreamento e o tratamento da vaginose bacteriana, é correto:

- A) Rastrear e tratar todas as mulheres assintomáticas
- B) Tratar somente as sintomáticas (e gestantes de risco conforme MS); não há indicação de rastreio em assintomáticas
- C) Tratar sempre o parceiro masculino
- D) Tratar apenas com antifúngico
- E) Nunca tratar gestantes

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual orientação reduz a recorrência da vaginose bacteriana?

- A) Realizar duchas vaginais frequentes
- B) Evitar duchas intravaginais e usar preservativo
- C) Suspender o metronidazol no 3o dia
- D) Abster-se de álcool obrigatoriamente
- E) Tratar o parceiro de rotina

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Corrimento fino acinzentado com odor de peixe + pH > 4,5 + clue cells + whiff positivo preenche os critérios de Amsel para vaginose bacteriana. Trata-se a sintomática com metronidazol VO 500 mg 12/12h por 7 dias.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O diagnóstico clínico de vaginose pelos critérios de Amsel exige pelo menos 3 de 4: corrimento característico, clue cells, pH > 4,5 e whiff test (teste das aminas) positivo.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O padrão-ouro é a coloração de Gram da secreção vaginal, que avalia a proporção entre lactobacilos e bactérias patogênicas (escore de Nugent).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Trata-se apenas a vaginose sintomática (e gestantes de risco conforme o MS); não há indicação de rastreio/tratamento em assintomáticas. Não se trata o parceiro de rotina.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Evitar duchas intravaginais e usar preservativo reduzem a recorrência da vaginose. A abstenção de álcool com metronidazol não tem embasamento (CDC); o parceiro não é tratado de rotina.

SM24
Suporte ao Plantão Médico